

接触镜毕竟是在人体眼球表面加了一层异物,如配戴不慎或盲目追求美观而不考虑自身条件,则有可能导致事与愿违的结果,这方面已有报道^[1,2]。我们通过长期的临床观察认为,第一,有些度数低、无屈光参差或很小,普通眼镜矫正视力良好而非特殊工种的患者,则不需配戴角膜接触镜。第二,必须配戴者应注意:①先到医院作眼科检查,若发现有沙眼、结膜炎、角膜炎等,必须治愈后方可配戴。②严格按配戴说明行事。③配戴期间注意眼部卫生和休息,周戴型镜片按日戴型使用。④在配有角膜接触镜的同时,最好再配一副普通眼镜

• 药物与临床 •

体外药物相互作用及其影响

王希海 曲国君[△]

北京军区总医院(100700)

临床上有关药物相互作用及由此而引起的药物不良反应已有大量报道,但对体外药物相互作用范围与性质的研究相对少一些。所谓体外药物相互作用,是指药物与药物、药物与容器之间,在未用于机体之前的相互作用。日常工作中,体外药物相互作用可以出现在药物治疗过程中,也可以发生在药物贮存的容器中。从对临床用药产生的影响看,体外药物相互作用所产生的后果,不同于体内药物相互作用所产生的不良反应(如中毒、药物无效以及引起器官和组织功能变化等)^[1]。前者药物间产生明显的理化变化,导致药物的生物利用度降低,增加药物毒性(在体内靶细胞部位产生),因此,了解体外药物相互作用关系,对临床安全有效用药具有指导意义。体外药物相互作用主要表现在以下几方面。

1 带有添加剂的针剂与输液剂之间的作用

某些难溶性药物为了制成针剂,需加入一些添加剂(附加剂)。这些针剂加入输液中,很可能发生意想不到的变化^[2]。所产生的产物可能是无活性的,也可能改变治疗作用(变成了另外一种有活性的药物),甚至产生毒性反应。这些反应在临床上有两种表现,一种是输液瓶中出现了沉淀、浑浊或变色,这一现象易被人们察觉,可以杜绝医疗事故的发生,即人们常见的药物配伍变化表中的配伍禁忌部分。但在很多情况下,产生反应时液体的外观无任何变化,这就很难预料会产生什么后果。因此,有人提出在今后的药物配伍时,应进行

以作替换,让眼休息一段时间。⑤一旦发现眼部不适,速停配戴角膜接触镜,到医院检查治疗;非戴镜不可,则用普通眼镜代替。第三,有些工种环境污染较大或个人卫生不易保持者,配戴角膜接触镜应慎重。

3 参考文献

- 1 申炳凤,郭培桓.亲水性软性角膜接触镜并发症临床分析.中华眼科杂志,1990,26:223
- 2 陈林.戴软接触镜致绿脓杆菌角膜溃疡1例.中华眼科杂志,1989,25:5

(1995-11-27 收稿 1996-04-15 修回)

含量测定,以保证临床配伍用药安全、有效^[3]。

2 药物同注射器的作用

注射器也可与针剂发生相互作用。例如盐酸阿霉素注射液与注射针头产生反应,出现沉淀或变色^[4];乙氧氮啶和胺苯吡啶可与塑料制品发生反应(一次性注射器)。故临床应用注射器时,应根据针剂的性质选用。

3 药物同容器的相互作用

有关药物在容器中的变化,详尽的资料目前尚少,但人们已经对药物与塑料材料相互作用、药物与玻璃瓶相互作用以及与输液管道中的醋酸纤维滤器结合等情况,有了初步认识。对静脉输液装置吸附药物情况的报道比较多,特别是塑料(聚氯乙烯)静脉输液容器(一次性输液器)、注射器、输液传递装置、滤器及其他附加装置,对药物的吸附作用。例如胺碘酮、安定、氯甲噻唑、胰岛素、盐酸利多卡因等,这些药物被吸附后药效明显降低。尤其是含量很低的药物,被吸附后已不再有治疗作用。在此有必要提醒人们高度重视这一现象。药物与容器的作用是一个比较新的研究课题,研究药物通过不同的塑料输液装置,进行模拟输液后损失的实验有了一定进展,相信不久的将来会有更好的输液装置材料出现,以弥补当今器具的不足。

通过以上分析,对体外药物相互作用给临床用药

[△] 内蒙古呼伦贝尔军分区医院(021008)

带来的危害已基本清楚。因此,我们建议,在输液过程中一般不提倡加入药物,在特殊情况下如抢救危重病人或治疗婴幼儿患者时,可适当加入所必需的药物,以一种药物为宜,若确定要联合用药,联合药物最好经另一输液管道,或第一组药液输完,再加另一组。一些等渗溶液(如 5%葡萄糖和 0.9%氯化钠)一般不会引起体液和电解质的变化,当加入大量其他药物时,将破坏其等渗性,很可能引起体液酸碱平衡失调,因此,含电解质、氨基酸、乳剂的药物,一般不主张加入其他药物,以防电解质平衡紊乱影响其他药物的分布吸收^[5]。为减少体外药物相互作用的发生,临床用药时应注意以下几点。

- (1) 在配伍操作过程中,两种药物混合时,一次只加一种药物到输液瓶中,待混合均匀后再加另一种。
- (2) 两种不同浓度的药物相配伍时,应先加浓度高的后加浓度低的,以减少发生反应的速度。
- (3) 有色液体应最后加入,以防止输液瓶内有细

小沉淀不易被发现。

(4) 在伍用时间上,应在机体允许的基础上尽快应用,以减少药物间的反应时间。

(5) 根据药物的性质选择好溶媒,避免产生理化变化。

4 参考文献

- 1 姜慕炎译. 药物不良相互作用手册. 北京: 中国医药科技出版社, 1991. 22~23
- 2 王士凡, 孙定人, 王功立, 等译. 药物不良反应. 北京: 人民卫生出版社, 1988. 23~25
- 3 周维书, 刘译培. 药物相互作用. 北京: 中国科学技术出版社, 1990. 67
- 4 杨大魁, 王宏图编译. 实用注射剂配伍变化 300 例. 上海: 上海翻译出版社, 1990. 103
- 5 陈世铭, 张志萍, 刘 屏, 等. 药物不良相互作用的临床意义与处理. 北京: 中国科学技术出版社, 1993. 5~6
(1996-03-12 收稿 1996-05-25 修回)

药 疹 43 例 分 析

阮黎明 沈奇范

浙江医科大学附属第一医院(310003)

我院皮肤科自 1992 年 1 月至 1995 年 5 月共收药疹住院患者 43 例,占同期该科住院病例的 13.8%。现将此 43 例作一回顾性分析。

1 临床资料

1.1 一般资料 男 26 例,女 17 例,男女比为

1.53:1。年龄 13~74 岁,平均 33.5±14.3 岁,其中 20~40 岁 28 例,占 65.1%。有药物过敏史者 11 例,占 25.6%;6 例(14%)为同种药物过敏。曾有其他过敏性疾病患者 6 例(14%)。

1.2 致敏药物与药疹类型 见附表。

附表 43 例的致敏药物与药疹类型

致敏药物	麻疹样型	荨麻疹型	多形性 红斑型	猩红热 样 型	固定型	大疱性表 皮松懈型	剥脱性 皮炎型	紫癜型	%
抗 生 素	11	2	3	2	—	1	1	—	46.5
解热镇痛药	5	1	2	—	—	1	—	—	20.9
复方新诺明	—	—	—	—	3	—	—	—	7.0
别 嘌 呤 醇	—	—	—	1	—	—	1	1	7.0
痢 特 灵	—	3	—	—	—	—	—	—	7.0
其 他	3	—	1	1	—	—	—	—	11.6
合 计	19	6	6	4	3	2	2	1	100.0

从表中可看出,以抗生素所致者最多,共 20 例,其

中头孢菌素 8 例、青霉素 6 例,其他为环丙沙星、乙酰